

06 - 02-Anatomie des paupières - Pr. KRIET

Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui l'anatomie des paupières. Le plan de secours est conçu. Après une introduction, nous allons voir l'anatomie descriptive, quels sont les muscles des deux paupières, le septum orbitaire et la charpente fibreuse, la fibrale, puis les annexes papillaux, puis la vascularisation et l'innervation avant de conclure.

En introduction, les paupières sont des lames qui est un musculo-membraneuse mobile, recouvrant en totalité la partie antérieure du globe oculaire. Il faut savoir que la paupière supérieure est beaucoup plus mobile que la paupière inférieure et vient recouvrir totalement la cornée lors de sa fermeture. Les paupières répondent à une triple fonction.

D'abord, elles protègent le globe oculaire. Elles jouent un rôle essentiel dans le drainage lacrymal et également d'expression mimique. Il existe deux paupières, supérieures et inférieures.

Quelques repères anatomiques à retenir. Le sourcil, le pli palpébral supérieur et le pli palpébral inférieur, le pli palpébral supérieur et le pli palpébral inférieur, le vore libre, la paupière supérieure et le vore libre, la paupière inférieure, le caroncule et le pli semilunaire. Ici, c'est la commissure médiane et la commissure latérale.

Les limites de la région palpébrale répondent au robot orbitaire au-delà, les paupières se continuent avec le tégument de la face sans qu'il y ait une limite bien définie. Classiquement, la région palpébrale est limitée au rôle par le vore inférieur, par le vore inférieur du sourcil. On va par le séant palpébrogénial et en dedans par la commissure palpébrale médiane qui réunit les deux paupières et la région nasale et en dehors, la commission latérale qui réunit les régions palpébrales et temporales.

L'anatomie descriptive des paupières, pour sa face antérieure, donc le plan cutané, chaque paupière présente un repli cutané parallèle au vore libre appelé C8 palpébral. Il faut retenir que la peau est extrêmement fine et le tissu cutané est rare. On trouve des plaies palpébraux qui constituent un repère capital pour la chirurgie des paupières.

Pour le pli palpébral supérieur, elle est très accentuée au-dessus duquel se dessine le creux sustarsal. Le résultat, c'est de l'insération cutanée de l'aponérose qui est mise au niveau de la paupière supérieure. Donc le repli palpébral supérieur et le repli palpébral inférieur.

Il est moins marqué par rapport au pli palpébral supérieur. La partie située entre le vore libre et le pli orbitopalpébral est appelée la portion tarsale des paupières. La portion tarsale des paupières, c'est-à-dire en rapport avec le tars des paupières.

Au-delà du sillon orbitopalpébral se trouve la portion orbitaire qui contient de la graisse recouverte d'une peau très mince. La face postérieure de chaque paupière est recouverte par la conjonctive palpébrale. Elle est rosée et lisse.

Donc sa convexité se moule sur la face antérieure de globocule. Chaque paupière présente un vore libre. Sa longueur est de 30 mm et son épaisseur est de 2 à 3 mm.

Donc un vore libre pour la paupière inférieure et un vore libre pour la paupière supérieure. Les deux vores libres limitent ce qu'on appelle la fronte papébrale. La fronte papébrale entre l'espace entre les deux vores libres.

Chaque vore libre présente deux portions. Une portion lacrimale interne, environ un cinquième de vore libre. Une portion lacrimale interne dépourvue du cil.

Une portion lacrimale interne pour la paupière supérieure. Une portion lacrimale inférieure pour le vore libre inférieur. Une portion cilière, 4 cinquièmes externes dépourvues du cil.

Ici, vous voyez le point lacrimal qui sépare la portion lacrimale et la portion cilière du vore libre. Ici le point lacrimal, ici c'est le vore libre dépourvu du cil, ici il est dépourvu du cil. Pour les angles des deux paupières, d'abord l'angle externe qui est formé par la réunion de deux vores libres.

Il est situé à 6 mm en dehors de l'orbitaire, le vore externe, et le vore interne formé par la réunion de deux paupières. Il contient deux formations, la caroncule et le repli subilinaire. Pour les tasses, on verra par la suite leur structure.

Elles représentent la charpente fibreuse des paupières. Les tasses sont des formations rigides. Pour le tasse supérieure, de forme ovale, le tasse supérieure de forme ovale entre le pli à pied-bras supérieur du vore libre de la paupière supérieure et pour le tasse inférieure, moins bien développée que le tasse supérieure, les deux tasses se réunissent pour former l'élégament papébral, l'élégament papébral interne et l'élégament papébral externe.

Sur cette courbe de profil de la paupière supérieure, c'est pour montrer la position du tasse au niveau de la paupière, le tasse supérieure. Ici, c'est entre le pli à pied-bras supérieur et le vore libre de la paupière supérieure. Quels sont les muscles rétracteurs des paupières ? D'abord, pour la paupière supérieure, c'est le muscle releveur de la paupière.

C'est un muscle qui permet l'ouverture papébrale et n'énervé pas le nerf monto-oculaire commun. Son origine se fait au niveau de l'apex orbitaire, au niveau du ton de dosine, avec les origines de droite supérieure et l'oblique inférieur. Son trajet se porte en avant entre droite supérieure et la paroi orbitale supérieure.

La terminaison du muscle releveur de la paupière se termine par un tendon terminal au fisson aponeuvrotique. Il est né de corps musculaires au regard de l'équateur du globe oculaire. Il forme un éventail soumolant sur le globe oculaire dont la base répond à toute la largeur de la paupière supérieure.

Pour les insertions de la paupière, les muscles releveurs de la paupière sont équipés d'abord

d'insertions cutanées, qui sont responsables des plaies papébrales supérieures, des insertions tarsales sur la moitié inférieure de la face externe de la tarse et des insertions osseuses qui donnent des aigrons externes et internes. À côté du muscle releveur de la paupière, il y a un autre muscle, le muscle de Miller, qui est né de la face inférieure du muscle releveur de la paupière et se termine sur le bord supérieur de la tarse. Ce schéma montre l'origine du muscle releveur de la paupière au niveau de l'apex orbitaire entre les muscles droits supérieurs et les muscles obliques supérieurs.

Ici, c'est le trajet de la releveur de la paupière, qui moule sur l'ongle oculaire et qui donne des insertions au niveau de la face inférieure de la tarse et des insertions cutanées qui traversent la cutanée et qui sont responsables des plaies papébrales. Sur ce photo, l'origine du muscle releveur de la paupière au niveau de l'apex orbitaire et qui présente deux portions, une portion horizontale orbitaire et une portion verticale papébrale et qui se termine par des insertions cutanées qui traversent la peau et qui sont responsables des plaies papébrales supérieures et des insertions tarsales, la moitié inférieure de la face externe de la tarse et des insertions osseuses au niveau des ailerons externes et internes. Ici, on voit très bien le muscle releveur de la paupière avec son insertion au niveau de la tarse.

Un autre muscle des paupières, c'est l'herbulaire. C'est un muscle qui est contenu dans l'épaisseur de la paupière. C'est un muscle plat, circulaire.

Il est aplati, mince et formé de plusieurs fissons. Il présente deux portions à décrire, la portion papébrale et orbitaire. C'est un muscle qui est énérvé par le nerf facial et qui joue un rôle dans l'occlusion papébrale.

L'herbulaire présente deux parties à décrire. D'abord, l'herbulaire orbitaire, il recouvre tout le portail osseux de la base de l'orbite. Il prône origine à la partie supérieure de la crête lacrymale antérieure pour se terminer à la partie inférieure de la crête lacrymale antérieure.

Et l'herbulaire papébrale qui est subdivisé en trois fissons aux trois portions. La portion marginale au muscle ciliaire du rioulant, elle est située dans le bord libre. La portion pré-tarsale, c'est-à-dire en avant de tarse, est née du tendon cantal interne.

Et la portion précipitale, c'est une portion très périphérique et elle est formée du fibre circulaire. Sur cette image, on distingue nettement les deux parties de l'orbulaire. L'orbulaire orbitaire périphérique et l'orbulaire papébrale.

Pour le muscle orbulaire orbitaire, il recouvre tout le portail osseux de la base de l'orbite. Il prône naissance au niveau de la partie supérieure de la crête lacrymale antérieure et se termine au niveau de la partie inférieure de la crête lacrymale antérieure. Donc l'origine de la partie supérieure de la crête lacrymale antérieure et la terminaison au niveau de la partie inférieure de la crête lacrymale antérieure.

Pour le muscle orbiculaire papébrale, il est subdivisé en trois portions, en trois fissons. D'abord une portion marginale au muscle ciliaire de Riholand. Elle est située dans le bord libre de la paupière.

Elle recouvre des bulles pileuses. Pour la portion pré-tarsale, la portion pré-tarsale qui est en avant de Tars, elle est née de tendons directs quant à l'interne et se dirige vers l'angle externe. Elle passe au niveau de la paupière inférieure pour se terminer au niveau de la face postérieure de tendons quant à l'interne.

Pour la portion préceptale, la portion périphérique de la portion papébrale à la portion préceptale, elle est formée de fibres circulaires qui s'insèrent sur la crête lacrymale postérieure et qui se terminent sur la crête lacrymale antérieure et la face postérieure de tendons directs quant à l'interne. À côté du muscle des paupières, nous allons voir maintenant le septum orbitaire et la charpente fibreuse. D'abord, le septum orbitaire.

Il se présente sous forme d'une lame fibreuse, d'une lame fibreuse mince, blanc, avec un accré qui rallie le rebord orbitaire au rebord périphérique de TARS. Il est plus résistant en périphérique qu'au centre. Il délimite la loge orbitaire.

Il livre passage aux éléments vasculonerveuse et assure la contention de la graisse orbitaire. En paupière supérieure, il possède des rapports étroits avec la pronébrance du muscle releveur de la paupière supérieure. En paupière inférieure, il est parfaitement séparé des expansions du rebord inférieur par des couches graisses.

La charpente fibreuse papébrale est assurée par le tasque. Il s'agit d'un tissu conjonctif, densifié, fibreux et élastique. Arrimé aux tendons et au septum, il forme la nature de la paupière.

Il est de dimensions onégales, en haut et en bas. Pour la paupière supérieure, il est de long de 30 mm et de 10 mm de large. Pour la paupière inférieure, il est de 20 mm de long et de 5 mm de large.

L'extrémité interne répond au point de l'acclimat. Il se situe à 10 mm de l'approfondissement du tendon maxilla supérieur. L'extrémité externe est à 7 mm de malheur.

Vous voyez ici la position de TARS. Le TARS supérieur est plus long et plus large que le TARS inférieur. Ici, c'est la même chose, une coupe sagittale qui montre la position de TARS au niveau de la paupière supérieure.

Ici, au niveau de la paupière supérieure, TARS supérieur et le TARS inférieur. Les éléments annexiels papébrales sont formés essentiellement par les glandes lacrymales suivantes qui assurent la sécrétion des larmes. Les glandes de Möbius qui sont contenues dans l'épaisseur du TARS et qui sont responsables de la sécrétion sévacée.

Puis, les glandes de Molle qui sont annexées au niveau du cil et qui sont responsables de la sécrétion supérieure. Et les glandes de Zeiss annexées au cil et au poil de paupière sont responsables de la sécrétion sévacée. Toutes ces glandes assurent la sécrétion lacrymale de base.

Pour la vascularisation des paupières, la vascularisation artérielle est assurée par les artères papébrales, branches de l'artérophthalmique. Il existe deux branches papébrales supérieures et inférieures. Ici, les artères papébrales, les branches collatérales de l'artérophthalmique, l'artère papébrale médiane supérieure et l'artère papébrale médiane inférieure qui donnent des branches responsables de la vascularisation des paupières par deux arcades, l'arcade papébrale périphérique et l'arcade papébrale marginale.

Sur ce schéma, on voit très bien la vascularisation artérielle des paupières, la paupière supérieure et la paupière inférieure, par les artères papébrales médianes supérieures, les artères médianes papébrales inférieures, qui donnent des arcades marginales, les arcades marginales périphériques et les acromionnes supérieures, qui s'alignent avec les artères papébrales latérales. La vascularisation veineuse, au niveau de la paupière supérieure, les veines internes sont drainées vers la veine jugulaire, au niveau de la paupière inférieure, les veines sont drainées vers la veine faciale. Pour la vascularisation lymphatique, il existe deux réseaux succutanés et surconjonctivats, ces deux réseaux donnent naissance au vaisseau lymphatique et sont drainés vers le congruent somaxilla.

Pour l'énervation des paupières, il existe deux types d'énervation, l'énervation motrice et l'énervation sans estive. L'énervation motrice pour le muscle lumaire est énercée par le système sympathique, le muscle releveur de la paupière supérieure est énercée par la branche supérieure de Troie et pour le muscle superficiel, ils sont sous le contrôle du nerf facial. Pour l'énervation sans estive, en ce qui concerne la paupière supérieure, elle est énercée par les branches de nerfs optométriques de Willis et la paupière inférieure est énercée par le nerf suborbitaire à la branche terminale du nerf axilla supérieur.

Ce diagramme montre la répartition de l'énervation motrice des paupières pour la paupière supérieure des branches collatérales du nerf Troie, le nerf suborbitaire, et pour la paupière inférieure, le nerf infrarobitaire. Même chose ici, l'énervation motrice de la paupière supérieure et la paupière inférieure par le nerf infrarobitaire et pour la paupière supérieure par le nerf infrasuborbitaire. En pratique clinique, quelques exemples des pathologies des paupières.

Ici à gauche, un ptosis, une ptose palpébrale, c'est la chute de la paupière supérieure qui résulte soit d'un déficit du muscle au niveau de la paupière supérieure, soit d'une désinsertion de ce muscle et de son aponeurose. Ici, installation fissurisée, ici c'est la même chose, installation de la paupière supérieure, installation, c'est une inflammation, ou enquistement d'une ou plusieurs glands de mybimus qui sont situés dans le tas de la paupière supérieure, donc qui forment des petites bulles de consistance ferme situées sous la peau et pourront être très douloureuses et qui

nécessitent parfois un traitement chirurgical. D'autres exemples de pathologies des paupières, ici une plaie en pleine épaisseur de la paupière inférieure, ici c'est la même chose mais avec un arrangement complet de la paupière inférieure, de son insertion au niveau de tendres comptes à l'interne, un corps étranger, la face postérieure de la paupière au niveau de la conjoncture palpébrale, ici un entropion qui est un roulement de bord libre vers l'intérieur, vers la cornée et qui est à l'origine d'une irritation, d'une inflammation de la cornée et de la conjoncture.

Des exemples de pathologies paupières, l'entropion, donc toujours le bord libre tourné vers l'intérieur, vers la cornée avec un trichiasisme et c'est l'entropion, c'est l'inverse de l'entropion avec le bord libre qui est tourné vers l'extérieur. Quelques exemples de pathologies tumorales des paupières, les tumeurs palpébrales sont très visibles à l'examen et apparaissent souvent sous forme de nodules, sous forme de nodules, ou des ulcérations de la paupière et parfois des angularités des bords libres de la paupière. L'emplacement le plus fréquent est la paupière inférieure, toujours la paupière inférieure, suivie du compass interne et de la paupière supérieure.

Pour conclure, on peut dire que les paupières forment de chaque côté deux structures cutané-musculaire-fibreuse. Elles jouent un rôle essentiel dans la protection de globes oculaires, mais également dans l'étalement du film lacrymase sur la cornée. Elles sont richement vascularisées et inirréveillées et les classiques de point de vue chirurgical de les séparer en deux portions verticalement, une portion tarsale et une portion septale.

Il y a également deux portions de l'océan sintéro-postérieur, une lamelle antérieure représentée par la peau et le muscle orbiculaire des paupières et une lamelle postérieure représentée par le tas et la conjoncture. Je vous remercie.